COMPRENDRE • FONDEMENTS INFIRMIERS

La discipline infirmière

Théories de soins, modèles conceptuels et raisonnement clinique • CM0 — Moodle, UE A1/S1

Pourquoi un cadre théorique ?

Un cadre rend visible la manière dont l'IDE comprend une situation et choisit ses observations et ses actions. Il donne une cohérence aux soins, soutient la continuité entre professionnels et aide à prendre du recul sur les gestes et les demandes médicales.

Idée directrice

Aucun soin n'est « sans théorie » : un cadre est toujours présent, explicite ou implicite. Le rendre explicite permet de mieux argumenter, transmettre et adapter le soin.

Repères historiques

1859	Florence Nightingale : structuration de la formation infirmière et premiers repères de la discipline.
1905	Léonie Chaptal : reconnaissance progressive de la profession.
1922	Diplôme d'État infirmier en France (repère présenté dans le cours).
À partir de 1950	Les soins infirmiers deviennent un objet de théorisation et de construction disciplinaire.

Vocabulaire à distinguer

CONCEPT	THÉORIE	MODÈLE
Idée abstraite qui aide à penser/décrire la réalité (ex. autonomie, douleur, environnement).	Ensemble organisé de concepts et de propositions qui les relient pour décrire, comprendre ou expliquer des phénomènes.	Structure de référence qui organise les concepts et oriente l'observation et l'action.

Repère : le modèle donne l'architecture ; la théorie explique le fonctionnement et les liens entre concepts. Ensemble, ils donnent du sens aux choix de soins.

Les 4 concepts centraux

PERSONNE	SANTÉ	ENVIRONNEMENT	SOIN
Individu, famille ou communauté ; être unique et global (dimensions physique, psychologique, sociale, spirituelle).	Bien-être physique, mental et social ; ne se réduit pas à l'absence de maladie.	Facteurs physiques, sociaux, culturels et économiques qui influencent la santé et la guérison.	Actions infirmières : promouvoir la santé, prévenir la maladie, soulager et accompagner.

COMPRENDRE • COURANTS DE PENSÉE

Six écoles, six éclairages

Elles proposent des focales complémentaires pour penser la relation et le projet de soins.

ÉCOLE	REPÈRE / THÉORICIENS	QUESTION UTILE EN SITUATION
Besoins	Virginia Henderson ; Dorothea Orem. Aider la personne à satisfaire ses besoins ou à développer son autonomie d'auto-soin.	Quelles capacités sont préservées ? Quel besoin est perturbé ? Quelle aide rend l'autonomie possible ?
Interaction	Hildegarde Peplau ; Paterson ; Zderad. Le soin est un processus relationnel et interpersonnel.	Comment établir une relation thérapeutique et comprendre l'expérience vécue ?
Effets souhaités	Callista Roy ; Marjory Gordon. Viser équilibre, stabilité et adaptation ; Gordon structure le recueil selon 11 modes fonctionnels.	Quels changements observer ? Quelles réponses d'adaptation soutenir ?
Promotion de la santé	Moyra Allen. Personne, famille et soignants partenaires ; l'IDE guide information, planification et évaluation.	Quels comportements et ressources peuvent améliorer la santé au quotidien ?
Être humain unitaire	Martha Rogers ; Rosemarie Parse. Personne et environnement forment une totalité en interaction ; santé et maladie sont des expressions de la vie.	Comment la personne donne-t-elle sens à son expérience et à son environnement ?
Caring	Jean Watson ; Madeleine Leininger. Prendre soin en respectant valeurs, croyances, culture et mode de vie.	Comment soutenir la personne avec présence, respect et attention aux signes d'évolution ?

Une même situation, plusieurs focales

Mme X, 78 ans, vit seule, vient d'être hospitalisée après une chute avec fracture. Elle est inquiète et refuse de se lever. Le cadre choisi ne remplace pas l'évaluation clinique : il aide à ne pas réduire la situation à la fracture.

Besoins	Interaction	Promotion / caring
Évaluer mobilité, douleur, sommeil, sécurité, autonomie et aides nécessaires.	Explorer la peur, écouter le vécu, clarifier ce qui rend le lever difficile.	Associer Mme X et ses proches aux objectifs, s'appuyer sur ses ressources et ses priorités.

À retenir : les écoles orientent le regard ; elles ne sont ni des protocoles ni des diagnostics. L'analyse s'appuie sur les données recueillies et les besoins exprimés.

COMPRENDRE • AUTONOMIE ET BESOINS

Henderson et Orem

École des besoins : aider sans faire à la place lorsque la personne peut participer.

Virginia Henderson : les 14 besoins fondamentaux

La personne est un tout complexe. L'IDE aide la personne malade ou en santé à réaliser les activités contribuant à la santé, au rétablissement ou à une fin de vie paisible, qu'elle accomplirait seule avec la force, la volonté ou les connaissances nécessaires.

01 Respirer	02 Boire et manger
03 Éliminer	04 Se mouvoir et maintenir une bonne posture
05 Dormir et se reposer	06 Se vêtir et se dévêtir
07 Maintenir la température du corps	08 Être propre, soigné et protéger ses téguments
09 Éviter les dangers	10 Communiquer
11 Agir selon ses croyances et ses valeurs	12 S'occuper en vue de se réaliser
13 Se récréer	14 Apprendre

Lecture clinique

Pour chaque besoin : recueillir ce que la personne fait seule, ce qui est difficile ou impossible, ce qu'elle sait/veut, les habitudes et le contexte ; repérer les effets sur sa santé et ses priorités.

Autonomie et auto-soin : deux repères

HENDERSON	OREM
L'IDE aide la personne à satisfaire un besoin lorsque ses forces, sa volonté ou ses connaissances sont insuffisantes, avec l'objectif de favoriser l'indépendance.	La capacité de la personne à prendre soin d'elle-même est centrale. L'aide infirmière répond au déficit d'auto-soin et soutient les capacités existantes.

Application au cas de Mme X

• Ne pas confondre refus et incapacité : rechercher d'abord la douleur, la peur, la compréhension du soin, les habitudes et les risques perçus.

• Évaluer avec elle : mobilité et transferts, douleur, équilibre, confiance, sommeil, élimination, environnement et aides disponibles.

• Co-construire : proposer un objectif progressif et réaliste, expliquer, recueillir son accord et réévaluer ses capacités.

• Transmettre : faits observés, paroles de Mme X, aide nécessaire, évolution et éléments à surveiller.

Rôle IDE et limites

Observer, écouter, recueillir, analyser, planifier, réaliser dans son champ de compétences, évaluer et transmettre. Respecter consentement, dignité et choix ; coordonner avec l'équipe et alerter en cas de risque ou de changement clinique.

COMPRENDRE • PASSER À LA PRATIQUE

Du modèle à l’action infirmière

Observer → orienter sa pensée → analyser et décider → agir → évaluer

Le modèle conceptuel soutient le raisonnement clinique

OBSERVER	ORIENTER	ANALYSER / DÉCIDER	AGIR / ÉVALUER
Données objectives et subjectives ; parole, capacités, contexte.	Choisir une grille de lecture et garder une vision globale de la personne.	Relier les données, repérer les besoins/ressources, prioriser et argumenter.	Mettre en œuvre un soin adapté, vérifier son effet, réajuster et transmettre.

En stage : mini-trame de réflexion

1. PERSONNE	2. SANTÉ	3. ENVIRONNEMENT	4. SOIN
Qui est la personne au-delà du motif d’hospitalisation ? Que dit-elle, que souhaite-t-elle ?	Quel est son état, son vécu, ses capacités, ses risques et ses ressources ?	Qu’est-ce qui facilite ou complique la situation à domicile et à l’hôpital ?	Quel objectif partagé ? Quelle action IDE ? Quel critère d’évaluation et quelle transmission ?

Pièges à éviter

Réduire la personne à son diagnostic ou au geste à faire • interpréter trop vite un comportement • imposer un objectif sans rechercher le sens du refus • confondre modèle théorique, protocole et décision clinique • oublier de vérifier l’effet du soin.

À mémoriser

4 concepts : personne • santé • environnement • soin | 6 écoles : besoins • interaction • effets souhaités • promotion • être humain unitaire • caring | Fil clinique : observer → analyser → décider → agir → évaluer.

Source du cours : Moodle, « CM0 — La discipline infirmière : théories de soins et modèles conceptuels », UE A1/S1, promotion 2026–2029. Repères bibliographiques cités dans le support : Taldir (2015) ; Le Neurès & Siebert (2009) ; Formarier & Jovic (2009) ; Guide du Service de Soins Infirmier, Terminologie des soins infirmiers ; Centre hospitalier de Carcassonne (2015–2018) ; cours IFSI Aurillac (2009).